Кому: Главному врачу ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 22» по Вершининой Лилии Геннадьевне

Копия: В Департамент здравоохранения г. Москвы

От: Гончара Сергея Григорьевича 23.05.1958 года рождения

Паспорт: серия 4506, 106997.
Выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО города Москвы 07.06.2003 года
Код подразделения 772-091

Адрес регистрации: 117036, Москва, улица Кедрова, дом 21, корпус 2, квартира 97

Социальный статус: Пенсионер, Неработающий.

Телефон: 8 985 957-90-58

E-mail: gs_soft@mail.ru

Дата составления: 26 сентября 2026 г.

ПРЕТЕНЗИЯ (ЖАЛОБА) о факте неоказания медицинской помощи, нарушении врачебной этики и психологическом давлении на пациента

1. Преамбула (Анамнез пациента)

Я, Гончар Сергей Григорьевич, 05 сентября 2026 года получил травму левого коленного сустава (повреждение при вставании из положения на корточках, сопровождавшееся резким хрустом, простреливающей болью по ходу большеберцового нерва и отеком). С указанной даты я официально состою на амбулаторном лечении в Поликлинике № 22 (ул. Кедрова, д. 24) у врача-хирурга Тамбиева А. В рамках лечения я лично за свои деньги сделал МРТ-исследование. Хирургом мне назначено консервативное лечение (ношение ортеза, тугих наколенников и физиотерапия и исследование мягких тканей). Но физиотерапия и исследование мягхих тканей начнутся во второй декаде Октября 2026г. Несмотря на проводимые процедуры, по состоянию на 26.09.2026 сохраняется острая импульсная боль при осевой нагрузке, вставание из положения приседа затруднено и сопровождается щелчками.

2. Хронология инцидента от 26.09.2026

26 сентября 2026 года, во второй половине дня, в связи с резким обострением болевого синдрома после неудачного шага на лестнице со ступеньками на улице, я обратился в Травматологический пункт Поликлиники № 22 по адресу Москва, ул. Кедрова, дом 24 для получения неотложной помощи.

- **Регистрация:**
- На стойке ресепшен я был официально зарегистрирован в электронной очереди. Сотрудник регистратуры направил меня в кабинет врача-ортопеда-травматолога Керимова М.И. Моя фамилия была транслировано по голосовой системе вызова пациентов. Я не выбирал кабинет самостоятельно и действовал строго по регламенту учреждения. Я пошел именно в тот кабинет, где прозвучал сигнал с моей фамилией.
- **Попытка передачи данных:**
- Войдя в кабинет, я предпринял попытку передать врачу USB-накопитель с записью МРТ, чтобы минимизировать время осмотра пациента с болью.
- **Реакция врача:**
- В ответ врач Керимов М.И. отреагировал неадекватно: начал громко кричать, вскакивать со стула, хаотично жестикулировать и требовать моего немедленного выхода из кабинета. На мои спокойные попытки показать заключение МРТ и объяснить причину визита врач не реагировал.
- **Фиксация отказа:**
- На мою законную констатацию факта: **«Вы отказываете мне в оказании медицинской помощи»,** врач Керимов М.И. впал в состояние крайнего раздражения, вышел из кабинета в коридор, позвал сотрудников службы безопасности (ЧОП) и в ультимативной форме потребовал вызвать наряд Росгвардии.
- **Поведение в холле:**
- Холл стал наполняться сотрудниками охраны. В этот момент я **понял**, что осмотра моего недуга и оказания медицинской помощи не последует. **Поэтому** я вышел из кабинета и медленно подошел к стойке ресепшен и находился там до конца этого инцидента.

  Прибытие наряда Росгвардии:

  Прибывший наряд Росгвардии (2–3 человека) провел первичный осмотр ситуации, убедился в отсутствии противоправных действий с моей стороны и не стал меня задерживать, покинув территорию поликлиники.
- **Дискредитация Пациента:**
- После отъезда наряда Росгвардии врач Керимов М.И. и сотрудники Охраны (в частности, высокий гражданин из Охраны) в течение 10–15 минут оставались в вестибюле. Они не вернулись к исполнению своих прямых обязанностей, а продолжали находиться в холле, указывая на меня и обсуждая мою персону.

  По визуальным признакам, произносили в мой адрес негативные характеристики, формируя у окружающих ложное представление о моей опасности. Были слышны слова и некоторые обрывки фраз в мой адрес – «Вот этот в белой Панаме» - показывая на меня. Эти слова произносил представитель Охраны так, чтобы и я слышал что они все обо мне думают.

  Данные действия выглядели как целенаправленная попытка публичной дискредитации пациента, а также создали нездоровую, напряженную обстановку для других посетителей.

- **Провокация к совершению противоправных действий:**
  Совокупность действий врача Керимова М.И. и сотрудников охраны носила характер спланированной провокации. Искусственно создавая ситуацию с вызовом Охраны, а затем и Росгвардии и демонстративно указывая на меня в холле с использованием оскорбительных характеристик («Вот этот в белой панаме»), они фактически провоцировали меня на ответную агрессивную реакцию. Я расцениваю данные действия как попытку создать повод для моего задержания или обвинения в нарушении порядка в общественном месте (хулиганстве), чтобы скрыть за этим факт собственного отказа в оказании медицинской помощи. Данные действия врача не имеют ничего общего с лечебным процессом и направлены исключительно на эскалацию конфликта.
- **Разрешение ситуации:**
  Спустя некоторое время ко мне подошел дежурный врач (терапевт, мужчина пожилого возраста). Мы с ним провели конструктивную беседу. Он пытался мне объяснить, что **Керимов М.И.** травматолог, а не ортопед.
  Но на всех публичных тематических сайтах, а также в других средствах массовой информации Врач **Керимов М.И.** представлен как Травматолог – Ортопед.
  Поэтому Я правильно обратился за медицинской помощью по профилю травматология-ортопедия.
  Также хочу заметить, что маршрутизация по кабинетам внутри учреждения является зоной ответственности регистратора на рецепшн, а не пациента. Я зашел ровно в тот кабинет откуда звучал сигнал приглашения войти в кабинет.

3. Правовая квалификация действий врача Керимова М.И.
Действия указанного сотрудника содержат признаки грубых нарушений законодательства РФ и должностных инструкций:

1. **Отказ в оказании медицинской помощи (ст. 11 ФЗ № 323):**
   Врач не провел пальпацию, не изучил предоставленное заключение МРТ, не оценил состоятельность текущего ортеза и отказал в минимальном объеме неотложной помощи (например, во внутрисуставной или периартикулярной обезболивающей блокаде), которая входит в стандарты травматологической помощи.
2. **Нарушение принципов деонтологии и этики:**
   Применение психологического давления, крик и агрессивная невербалика в отношении пациента с подтвержденной травмой и острым болевым синдромом.
3. **Злоупотребление должностными полномочиями:**
   Необоснованный вызов сотрудников Росгвардии и частной охраны для эскалации бытового конфликта с безоружным пациентом, что создало необоснованную психологическую нагрузку на меня и других пациентов.
4. **Нарушение порядка маршрутизации:**
   Перенос ответственности за ошибку сотрудника регистратуры на пациента в Выборе Направления - Травматология вместо Ортопедии.

5. **Грубое обращение с социально уязвимой категорией граждан:** Обращаю внимание, что я являюсь неработающим пенсионером (1958 г.р.). Врач Керимов М.И., обладая информацией о моем возрасте и наличии острой травмы, не проявил должного уважения к возрасту пациента и его социальному статусу. Применение агрессивного психологического давления, крика и необоснованный вызов силовых структур в отношении пожилого человека с подтвержденным повреждением опорно-двигательного аппарата является отягчающим обстоятельством и демонстрирует полное пренебрежение врачебной этикой.

4. Требования

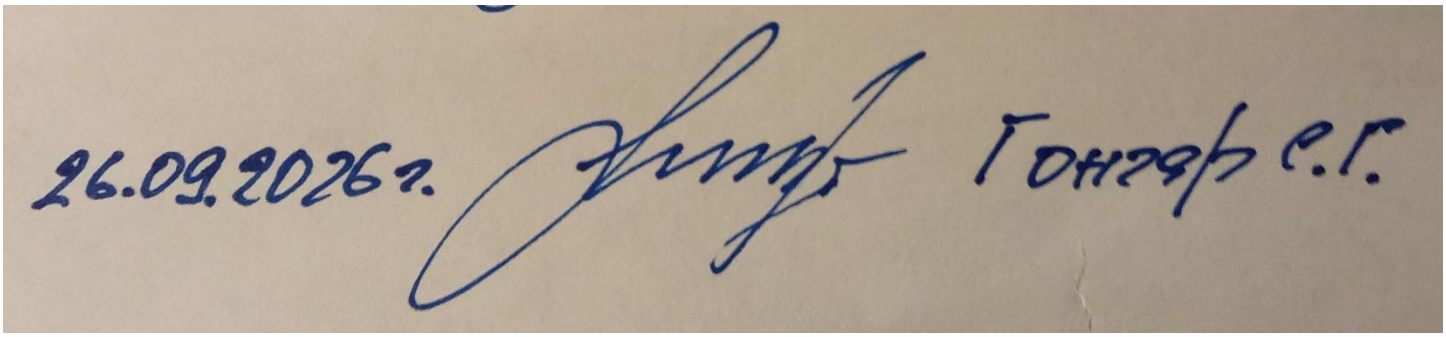
На основании изложенного, руководствуясь ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ПРОШУ:

1. Провести внутреннюю служебную проверку по факту инцидента с изучением записей с камер видеонаблюдения поликлиники (в холле и у регистратуры) за 26.09.2026 во второй половине дня. Или прямо по сюжету, где участвуют вышеупомянутые лица.
2. Провести очную дисциплинарную беседу с врачом **Керимовым М.И.** и предоставить мне информацию о принятых мерах дисциплинарного взыскания.
3. Обеспечить мое беспрепятственное получение медицинской помощи в данном учреждении в дальнейшем без риска психологического давления.
4. Предоставить мне письменный ответ по существу претензии в установленный законом 30-дневный срок на указанный почтовый и электронный адрес.
5. Принести официальные письменные извинения за непрофессиональное поведение сотрудника.

Приложения:

1. Копия заключения МРТ от 22.09.2026

26 сентября 2026 г. _____ /Гончар С.Г./



ABC | медицина ниармедик
ВМЕСТЕ

Медицинская документация
Форма №025/у
Утверждена приказом
Минздрава России
от 13 мая 2025 года №274н

http://abc-medicina.com 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 10, офис 2 ком 17 т.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЁННОЙ СЕТИ

Актуальные акции и предложения по QR-коду

МРТ Исследование

Дата приема: **22.09.2026** Номер карты: **250010711**

Пациент: **Гончар Сергей Григорьевич**

Дата рождения: **23.05.1958** Возраст: **68**

Врач: **Цыбенов Юнрин Юрьевич**

Категория **Наличный расчет**

1 102500 136674

Наименование исследования: мрт коленного сустава.

Детализация: Левый(ая)

Жалобы, анамнез: Боль с внутрен. стороны кс, травм нет.

Протокол обследования: Костные структуры, образующие коленный сустав, имеют заостренные края эпифизов в пателло-феморальном сочленении.
Определяется II тип по Wiberg строения надколенника, гипоплазия медиального мыщелка бедренной кости.
Интенсивность сигнала от костного мозга изменена по типу отёка в субхондральных отделах медиальных мыщелков в наружных отделах, где суставные поверхности мыщелков с неровностью.
Толщина суставного хряща не уменьшена.
Мениски клиновидной формы во фронтальной и сагиттальной плоскостях, в заднем роге медиального мениска гиперинтенсивный мр-сигнал, доходящий до нижней суставной поверхности.
Передняя и задняя крестообразные, большеберцовая и малоберцовая коллатеральные связки прослеживаются на всем протяжении, структура их не изменена.
В супрапателлярной сумке, полости сустава определяется наличие умеренного патологического количества жидкости.
Медиопателлярная синовиальная складка, не доходящая до мыщелка.
Между медиальной головкой икроножной и головкой полуперепончатой мышц жидкостное образование размерами 28*9*28 мм.
Мягкие ткани, окружающие коленный сустав, и проходящие рядом кровеносные сосуды без патологических изменений.

Заключение: мр-признаки отёка костного мозга в субхондральных отделах медиальных мыщелков (возможно начальные проявления аваскулярного некроза), повреждения IIIa ст. по Stoller заднего рога медиального мениска. Умеренный синовит. Киста Бейкера. Медиопателлярная синовиальная складка, тип B по Sakakibara. Начальный пателло-феморальный остеоартроз.

Рекомендации: консультация ортопеда, КТ сустава, динамика.

Модель томографа: GE Brivo MR355 1,5 T.

Врач:_____ Цыбенов Юнрин Юрьевич

ABC | медицина ниармедик
ВМЕСТЕ

Медицинская документация
Форма №025/у
Утверждена приказом
Минздрава России
от 13 мая 2025 года №274н

http://abc-medicina.com 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 10, офис 2 ком 17 т.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЁННОЙ СЕТИ

Актуальные акции и предложения по QR-коду

МРТ Исследование

Дата приема: **22.09.2026** Номер карты: **250010711**

Пациент: **Гончар Сергей Григорьевич**

Дата рождения**: 23.05.1958** Возраст**: 68**

Врач: **Цыбенов Юнрин Юрьевич**

Категория **Наличный расчет**

1 102500 136674

Я, Гончар Сергей Григорьевич, имел(а) возможность задать врачу интересующие меня вопросы относительно моего здоровья,заболевания, лечения и получил(а) удовлетворительные ответы; претензии к приему и осмотру не имею, согласен/согласна с данными рекомендациями по обследованию и лечению, в чем расписываюсь собственноручно:

_____

Врач:_____ Цыбенов Юнрин Юрьевич